

作业治疗学期末知识点整理

基于期中选择题与主观题知识点整理 / 含英文关键词、考点与病例答题模板

使用方法：优先背“考试重点”和表格中的英文关键词；主观题按“定义—分析—评估工具—干预策略—预期结果”的结构作答。

一、作业治疗基础概念

Occupation 作业

- 指对个体有意义、有目的的日常活动，而不是单纯“职业/工作”。
- 包括 self-care 自理、productivity 工作/学习、leisure 休闲、social participation 社会参与。

考试重点：Occupation = meaningful and purposeful activities. 不能理解为 only work.

Occupational performance 作业表现

- 指个体完成作业活动的能力。
- 核心来自 Person 人、Environment 环境、Occupation 作业三者互动。

考试重点：Occupational performance depends on interaction among person, environment and occupation.

PEO Model 人—环境—作业模型

- Person：身体、心理、认知、兴趣、角色等。
- Environment：物理、社会、文化、制度等。
- Occupation：有意义、有目的的活动。
- 三者匹配度越高，作业表现越好。

考试重点：PEO = Person + Environment + Occupation.

Meaningful occupation 有意义作业

- OT 不只是 exercise 或 physical training。
- 强调患者真实生活需要、角色、兴趣、参与感、独立性和生活质量。
- 例如 Mrs. Li 喜欢园艺、做饭、太极，训练就应融入这些真实活动。

考试重点: Meaningful occupation improves motivation, functional performance, identity and long-term participation.

Life Reconstruction-Based Approach 生活重建导向方法

- 重点不是单纯恢复身体功能，而是帮助患者在疾病或残疾后重新建立有意义、自主的生活。
- 关键词：生活重建、真实生活需要、社会参与、独立生活、角色恢复。

二、作业治疗流程与原则

OT process 作业治疗流程

- Assessment 评估。
- Treatment planning 制定治疗计划。
- Intervention implementation 实施干预。
- Reassessment 再评估。

考试重点: Surgical intervention 外科手术干预不属于作业治疗流程。

治疗性作业活动设计第一步

- 第一步是评估患者需求和功能状态。
- 不要一开始就选择最复杂活动或直接训练。

考试重点: Assess the patient's needs and functional status first.

Patient-centred care 以患者为中心

- 尊重患者自主性。
- 共同设定目标。
- 关注患者角色、生活史、兴趣和真实需求。
- 常用工具：COPM。

考试重点: COPM 可帮助找出患者认为最重要的作业问题。

Individualization principle 个体化原则

- 根据患者个人优势、兴趣、能力、环境和社会资源制定计划。
- 不是所有患者统一训练。

考试重点: Develop plans based on individual strengths, needs and interests.

三、ADL / IADL 与常用评估工具

ADL 日常生活活动

- 基础 ADL 包括洗澡、穿衣、如厕、进食、转移、移动等。
- 常用评估：Barthel Index、FIM。

FIM 功能独立性评定

- 共有 18 items。
- 包括 13 项运动项目 + 5 项认知项目。
- 每项 1-7 分，总分 18-126 分。

考试重点： FIM assesses 18 items.

IADL 工具性日常生活活动

- 比 ADL 更复杂，与社区独立生活有关。
- 包括打电话、购物、做饭、家务、洗衣、交通、服药、理财。
- 常用评估：Lawton IADL Scale。

考试重点： Lawton IADL Scale assesses instrumental activities of daily living, not basic self-care.

四、环境适配 Environmental adaptation

认知障碍老人居家适配

- 中度认知障碍、独居老人，适合清晰标识、固定物品摆放、简化流程。
- 不要增加家务任务、复杂智能家居或随意大规模挪家具。

考试重点： clear labeling, consistent object placement, simplified routines.

环境适配分类

- Physical structure modification：加宽门、坡道、扶手。
- Assistive technology：沐浴椅、助行器、语音输入。
- Interpersonal environment adaptation：调整患者与治疗师、家属关系。
- Virtual environment adaptation：屏幕阅读软件、人体工学键盘、鼠标灵敏度、语音输入。

考试重点： 加宽门道属于 physical environment，不属于 virtual environment。

Shower chair 沐浴椅

- 给下肢无力患者提供沐浴椅属于辅助技术。

考试重点: Providing assistive technology.

五、转移、穿衣与移动

床上坐起 Bed-to-sitting transfer

- 双下肢功能障碍患者从卧位到坐位，第一步是先翻身侧卧。
- 之后用手臂支撑躯干，同时把双腿移到床边。

考试重点: Bed-to-sitting starts with rolling to one side / side-lying.

偏瘫患者轮椅到床转移

- 原则：向健侧转移。
- 左侧偏瘫 = 右侧健侧。
- 轮椅摆放 30-45°，健侧靠近床。

考试重点: Wheelchair positioned at 30-45° with the unaffected side toward the bed.

单手穿开衫 / 扣衫 One-handed dressing

- 核心原则：先穿患侧，健手操作。
- 右偏瘫时，用左手帮助右患侧手臂先进入袖子，再穿健侧。
- 扣扣子时可从下往上扣，便于对齐。

考试重点: Dress the affected side first.

手杖与腋拐测量

- 手杖高度：到 greater trochanter 股骨大转子；肘关节屈曲 20-30°。
- 腋拐 handgrip：到 ulnar styloid process 尺骨茎突水平；肘关节屈曲 20-30°。

考试重点: Cane length equals the height of the greater trochanter.

Four-point gait 四点步态

- 顺序例子：右拐 → 左脚 → 左拐 → 右脚。
- 特点：最稳定、最慢，至少三点支撑在地面。
- 适用：双下肢可负重、能独立移动双腿，但需要额外稳定性。

- 不适合：一侧完全不能负重、术后禁止负重、需要快速行走者。

六、跌倒风险 Falls risk

跌倒危险因素

- 内在因素 intrinsic factors：生理、病理、药物、心理因素。
- 外在因素 extrinsic factors：地滑、光线暗、障碍物、地毯松动等环境因素。

考试重点： Environmental factors are extrinsic, not intrinsic.

常用评估

- TUG：移动能力、跌倒风险。
- Berg Balance Scale：平衡能力。
- Tinetti POMA：步态和平衡。
- FES-I：跌倒恐惧、自我效能。

七、注意、认知与心理

Sustained attention 持续性注意

- 在较长时间内对单一任务、刺激或活动保持注意，也叫 vigilance。
- 题目例子：数字听写 dictation of numbers。

考试重点： Dictation of numbers 需要持续听和持续集中注意力。

Unilateral neglect 单侧忽略

- 患者忽略患侧空间刺激。
- 轮椅驾驶时最可能撞到患侧障碍物。

考试重点： Collide with obstacles on the affected side.

CBT 的 ABC 模型

- A = Activating event 诱发事件。
- B = Beliefs 信念 / 想法。
- C = Consequences 情绪和行为结果。
- 同一事件导致不同结果，关键在个体信念。

考试重点: B represents beliefs about the event.

Motivational interviewing 动机性访谈

- 目的: 增强患者行为改变的内在动机。
- 不是替患者做决定, 也不是直接命令患者。

考试重点: Enhance the patient's intrinsic motivation for behavior change.

Mental disorder 精神障碍

- 指认知、情绪调节或行为方面出现具有临床意义的紊乱。
- 通常伴随痛苦 distress 或功能受损 impairment。
- 需要考虑文化和社会规范。

考试重点: A mental disorder is a clinically significant disturbance in cognition, emotional regulation or behaviour, associated with distress or functional impairment.

八、脑损伤 Brain injury 作业治疗

急性期 Acute stage

- 主要目标: 预防并发症、保护患侧肩、良肢位摆放、早期坐起。
- 病情允许时, 早期采用床上坐位或床边坐位。

考试重点: Sitting in bed or at the bedside is appropriate when medically stable.

恢复期 Recovery phase

- 核心目标: 最大程度恢复功能, 提高 ADL 独立性。

考试重点: Maximizing functional recovery and independence in ADL.

双手环圈 / 推滚筒活动

- 主要目的: 促进患侧肩胛骨上抬 / 前伸, 保护肩关节。
- 不是主要练认知、健侧精细运动或有氧。

Shoulder sling 肩吊带

- 白天直立活动时佩戴, 卧床休息时可取下, 并用枕头支撑。
- 目的: 减少重力牵拉, 预防肩半脱位。
- 不能 24 小时一直戴, 避免挛缩。

考试重点: Worn during daytime activities and removed during bed rest.

Brunnstrom Stage III

- 可以主动引发共同运动 synergy patterns。
- 痉挛达到高峰。

考试重点: Voluntary synergy patterns can be initiated; spasticity peaks.

九、脊髓损伤 SCI 与 ASIA

ASIA 感觉平面

- 感觉平面 = 感觉正常的最低皮节。
- 例：L3 股骨内侧髁感觉正常，L4 内踝感觉消失，则感觉平面为 L3。

考试重点: Sensory level is the most caudal dermatome with normal sensation.

ASIA 10 对关键肌

- C5 elbow flexors; C6 wrist extensors; C7 elbow extensors; C8 finger flexors; T1 finger abductors.
- L2 hip flexors; L3 knee extensors; L4 ankle dorsiflexors; L5 long toe extensors; S1 ankle plantar flexors.
- 不包括 knee flexors / hamstrings.

考试重点: Knee flexors / hamstrings are not ASIA key muscles.

Neurogenic bladder 神经源性膀胱

- 由于神经系统损伤或疾病导致膀胱储尿和排尿功能障碍。
- 表现：尿失禁、尿潴留、尿频等。
- 可分为痉挛性膀胱、弛缓性膀胱。

SCI 急性期 OT 作用

- 良肢位摆放 positioning。
- ROM 维持关节活动度。
- Splinting 支具固定。
- 预防挛缩、畸形、压疮。
- 管理水肿，保护上肢功能。
- 完成基线评估，提供心理支持和患者/家属教育。

- 四肢瘫患者注意保留 tenodesis grasp 腱固定抓握。

考试重点：急性期重点是预防和支持，不是马上强调完全独立生活。

T6 完全性 SCI 出院前居家评估

- 出入口：坡道、门宽 ≥ 80 cm、无台阶。
- 室内：轮椅转弯空间，最好单层生活。
- 卫浴：无障碍淋浴、扶手、坐便/淋浴椅。
- 卧室：床高合适，有转移空间。
- 厨房：台面和储物高度适合轮椅。
- 压疮预防：轮椅坐垫、减压床垫。
- 自主神经反射异常风险：紧急处理方案、通讯设备可及。
- 照护者训练和经济/改造资源转介。

十、手外伤、矫形器与压力治疗

掌侧手部创伤 Volar / palmar hand wounds

- 最容易导致 flexion contractures 屈曲挛缩。
- 因为掌侧瘢痕收缩会把手指牵拉向屈曲位。

考试重点：掌侧损伤常需要把手固定在伸展位来对抗挛缩。

手部损伤长期制动

- 最可能导致 joint stiffness and pain 关节僵硬和疼痛。
- 条件允许时要早期活动。

Hand orthoses 手部矫形器

- 作用：保护术后结构、预防关节挛缩、维持腕功能位、辅助拇指外展。
- 不能替代神经修复。

考试重点：Orthoses cannot replace nerve repair.

稳定性骨折的矫形器

- 可作为简单外固定，替代石膏。
- 不能替代手术内固定、让骨折瞬间愈合、完全替代肌肉功能。

Upper-limb suspension frame 上肢悬吊架

- 承托上肢和石膏重量。
- 减轻肢体负荷，方便关节活动，帮助控制肿胀。

考试重点： Reducing limb and cast weight to facilitate joint movement.

Compression therapy 压力治疗

- 为了防止远端水肿，压力治疗必须同时覆盖远端节段。
- 如果只压近端，液体可能被推到未加压的远端。

考试重点： Apply compression to distal segments simultaneously.

十一、骨折术后康复与职业康复

术后 4-8 周

- 可关注疼痛和肿胀控制、ADL 辅具使用、逐渐恢复 ROM、恢复肌力。
- 不能立即回到高强度竞技运动。

考试重点： Immediate return to high-intensity sport is inappropriate.

有工作需求的骨折患者

- 重返工作前应做 vocational functional assessment 职业功能评估。

Vocational rehabilitation 职业康复原则

- 根本原则：Equality 平等原则。
- 残疾人享有平等的培训、就业和工作机会。
- 个体化原则：根据能力、兴趣、优势、环境和资源制定计划。

考试重点： Equality is the basic principle.

十二、儿童作业治疗与其他考点

Play assessment 游戏评估

- 游戏最能显示儿童最高水平能力。
- 尤其能体现手功能、认知功能、人际关系。

考试重点: Play can reveal hand function, cognitive function and interpersonal relationships.

Behavioral performance components 行为表现成分

- 包括活动所需基本功能、运动类型、动作基本步骤、完成动作的方式。
- 不包括 methods of medication use 用药方法。

十三、常用评估工具速记表

工具	主要用途	考试记忆点
COPM	患者中心评估, 找出患者认为重要的作业问题	适合用于共同设定目标
Barthel Index	基础 ADL 独立性	洗澡、穿衣、如厕、进食、转移等
FIM	功能独立程度	18 items; 13 运动+5 认知
Lawton IADL	工具性日常生活活动	做饭、购物、交通、服药、理财等
TUG	移动能力与跌倒风险	起立—行走—转身—坐下
Berg Balance Scale	平衡能力	老年人/神经系统常用
Tinetti POMA	步态和平衡	跌倒风险相关
FES-I	跌倒恐惧与自我效能	害怕跌倒时可用
MMT	肌力	0-5 级
Goniometry	关节活动度 ROM	量角器测 ROM
NRS/VAS	疼痛强度	0-10 或视觉模拟

十四、Mrs. Li 病例主观题模板

病例核心: 右下肢 ORIF 术后 6 周, 允许 full weight-bearing as tolerated。右髋屈肌和股四头肌 MMT 3/5, 髋 ROM 减少, 疼痛 NRS 静息 5/10、活动 7/10。用标准助行架短距离行走, 易疲劳, 怕跌倒。洗澡和下身穿衣需要中等帮助, 不能上下楼。住两层楼, 喜欢园艺、给孙辈做饭、每周三次太极。

1. 功能障碍分析 + 评估工具

领域	主要问题	可用评估工具
神经肌肉骨骼功能	肌力弱、ROM 下降、疼痛	MMT、Goniometry、NRS/VAS
ADL	洗澡、下身穿衣中等帮助	Barthel Index、FIM
移动与跌倒	助行架、疲劳、不能上楼、怕跌倒	TUG、Berg、Tinetti POMA
心理功能	害怕跌倒、信心下降	FES-I、PHQ-9
IADL/角色/环境	做饭、园艺、太极、两层住宅困难	COPM、Lawton IADL、HOME

		FAST
--	--	------

2. 康复阶段判断

- 她属于 Subacute phase 亚急性期。
- 理由：术后 6 周，已允许 full weight-bearing as tolerated。
- 重点从保护转向恢复力量、耐力、ADL 独立、移动安全、信心和作业参与。

3. 4 周 OT 计划

阶段	训练重点	示例内容
Week 1	评估与基础训练	COPM 确定优先目标；reacher、sock aid、long-handled sponge、shower bench；坐位下身穿衣；疼痛管理和节能教育
Week 2	ADL 再训练 + 功能性强化	洗澡和穿衣训练；sit-to-stand；台面站立任务；轻度厨房活动；平衡训练和跌倒预防
Week 3	移动、IADL 与居家准备	与 PT 合作练楼梯；模拟简单做饭；家访/居家改造；园艺分级活动；跌倒恐惧暴露训练
Week 4	巩固与出院准备	完整 ADL 流程；模拟做饭、园艺、太极；训练丈夫支持；安排家庭训练和社区资源；重新评估 COPM

4. 患者中心原则应用

- 先解释原则：尊重 Mrs. Li 的自主性，通过 COPM 共同设定目标，围绕真实角色和兴趣，而不是只治疗肌力和 ROM。
- 策略 1：以做饭作为作业本位训练。从坐位备菜逐渐过渡到台面站立做饭，可使用 perch stool 和节能技术。预期结果：安全恢复给孙辈做饭，提高站立耐力，恢复祖母/照护者角色。
- 策略 2：分级回归园艺。使用 raised beds、container gardening、long-handled tools、kneeler/seat，并结合 pacing。预期结果：安全恢复园艺活动，提高下肢力量、耐力、情绪和生活质量。

十五、考前优先背诵清单

1. PEO、occupation、occupational performance、meaningful occupation。
2. FIM 18 项、Lawton IADL、COPM、TUG/Berg/FES-I。
3. 偏瘫转移：轮椅 30-45°，健侧靠床。
4. 单手穿衣：先穿患侧。
5. 手杖到股骨大转子；腋拐手柄到尺骨茎突。
6. ASIA 感觉平面和 10 对关键肌；knee flexors 不包括在内。

7. Brunnstrom III: 共同运动可引出, 痉挛高峰。
8. SCI 急性期 OT: 摆位、ROM、支具、压疮预防、教育和心理支持。
9. 四点步态: 稳定但慢, 适合双下技能负重但需稳定者。
10. Mrs. Li: 亚急性期 + 4 周 OT 计划 + 患者中心策略。